ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

Cours de 6e année de médecine
Unité : Santé au travail et environnement (STE)

Dr S. LEBOUABI
Maitre-assistant en médecine du travail

Objectifs pédagogiques

1) Définir un accident du travail, une maladie professionnelle et une maladie à caractère professionnel ;
2) Définir une incapacité temporaire, une incapacité permanente, la guérison et la consolidation ;
3) Décrire les procédures de déclaration d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle et la logique de signalement d'une maladie à caractère professionnel ;
4) Expliquer les modalités générales de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
5) Repérer l'intérêt de la déclaration pour le travailleur, l'employeur, le praticien médical et la prévention ;
6) Citer les critères de reconnaissance d'une maladie professionnelle indemnisable.

Plan du cours

1. Accidents du travail

1.1. Définitions, situations assimilées et bénéficiaires
1.2. Caractéristiques de l'accident du travail
1.3. Imputabilité médicale
1.4. Constitution du dossier
1.5. Aggravation et rechute de l'accident du travail
1.6. Déclaration de l'accident du travail
1.7. Données statistiques des AT, accidents de trajet, AT mortels et impact socio-économique

2. Maladies professionnelles

2.1. Définitions des maladies professionnelles et des maladies à caractère professionnel
2.2. Tableau de maladie professionnelle
2.3. Modèles de réparation des maladies professionnelles
2.4. Présomption d'imputabilité
2.5. Déclaration des maladies professionnelles et des maladies à caractère professionnel
2.6. Statistiques des maladies professionnelles et des maladies à caractère professionnel

3. Reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles par la CNAS

4. Prestations des accidents du travail et des maladies professionnelles

5. Synthèse pratique et prévention

Corpus du cours

Les accidents du travail et les maladies professionnelles constituent un champ central de la santé au travail, à l'interface de la clinique, du droit social, de la sécurité sociale et de la prévention. En Algérie, leur cadre juridique repose principalement sur la loi n°83-13 du 2 juillet 1983 et ses textes d'application.

Les AT/MP ne doivent pas être réduits à des formalités administratives. Ils constituent un champ médico-légal structurant, où la précision clinique, la compréhension des textes et la prévention des risques professionnels se rejoignent. La loi n°83-13 demeure la référence principale en Algérie pour les définitions, la déclaration, les certificats, la reconnaissance et les prestations (1). Les textes d'application, notamment le décret n°84-28, l'ordonnance n°96-19 et le décret exécutif n°97-424, complètent ce dispositif en précisant les modalités pratiques et les aspects de prévention (2-4).

À l'échelle internationale, l'OIT rappelle que les accidents et maladies liés au travail provoquent près de trois millions de décès par an et que la prévention doit constituer un objectif prioritaire des politiques de travail (7). L'OMS insiste sur la protection des travailleurs exposés aux risques physiques, chimiques, biologiques, ergonomiques et psychosociaux, notamment dans le secteur de la santé (9).

1. Accidents du travail

1.1. Définitions, situations assimilées et bénéficiaires

1.1.1. Définitions de l'accident du travail

En droit algérien, l'article 6 de la loi n°83-13 définit l'accident du travail comme *tout accident ayant entraîné une lésion corporelle, imputable à une cause soudaine, extérieure, et survenu dans le cadre de la relation de travail* (1). Cette définition associe quatre idées indispensables : l'existence d'un événement accidentel, une lésion corporelle, une soudaineté et un lien avec l'activité professionnelle.

La constatation médicale ne vaut pas reconnaissance juridique. Le médecin décrit les lésions, apprécie leur cohérence avec les circonstances rapportées et rédige les certificats; l'organisme de sécurité sociale instruit ensuite le dossier et décide de la reconnaissance (1). Cette distinction est essentielle : le certificat doit rester médical, descriptif et objectif.

Sont également considérés comme accidents du travail certains accidents survenus au cours *d'une mission accomplie hors de l'établissement conformément aux instructions de l'employeur, au cours de l'exercice d'un mandat électoral, dans le cadre d'études suivies régulièrement en dehors des heures de travail, pendant des activités sportives organisées par l'organisme employeur, ou lors d'un acte de dévouement dans l'intérêt public ou de sauvetage d'une personne en danger* (2).

1.1.2. Accident de trajet

L'accident de trajet est assimilé à un accident du travail lorsqu'il survient pendant le trajet normal effectué par l'assuré pour se rendre à son travail ou en revenir, quel que soit le mode de transport utilisé, à condition que le parcours n'ait pas été interrompu ou détourné pour un motif étranger au travail, sauf urgence, nécessité, cas fortuit ou force majeure (1).

Le trajet protégé comprend le parcours entre le lieu de travail et le lieu de résidence, ou un lieu assimilé où le travailleur se rend habituellement, notamment pour prendre ses repas ou pour des motifs d'ordre familial. Les éléments à documenter sont le lieu, l'heure, le parcours, le mode de transport, les circonstances et les lésions observées.

1.1.3. Accidents du travail mortels

Un accident du travail est mortel lorsque le décès survient immédiatement après l'événement, secondairement du fait des lésions initiales ou lorsque les lésions ont accéléré le décès. L'article 9 de la loi n°83-13 fonde la qualification lorsque le décès survient au temps et au lieu de travail, alors que le travailleur est sous la subordination de l'employeur (1).

1.1.4. Présomption d'imputabilité du décès au travail

Lorsque le décès survient au temps et au lieu du travail, alors que le travailleur est placé sous la subordination de l'employeur, il existe une présomption d'imputabilité au travail, sauf preuve contraire. L'analyse médicale doit néanmoins rester rigoureuse : elle tient compte de la nature des lésions, du délai entre l'événement et le décès, des complications, de l'état antérieur et de la plausibilité physiopathologique du lien causal (1).

1.1.5. Bénéficiaires du régime AT/MP

Sont couverts les travailleurs assujettis aux assurances sociales, quelle que soit leur nationalité, dès lors qu'ils exercent sur le territoire national pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient la nature du contrat, le mode ou le montant de rémunération et le lieu d'exercice (1).

Sont également concernés certaines catégories assimilées, notamment *les élèves des établissements d'enseignement technique, les personnes en stage de rééducation fonctionnelle ou de réadaptation professionnelle, les participants bénévoles au fonctionnement des organismes de sécurité sociale, les pupilles relevant de la sauvegarde de la jeunesse pour les accidents liés à un travail commandé, les détenus exécutant un travail pendant leur peine et les étudiants dans les conditions prévues par les textes* (1).

1.2. Caractéristiques de l'accident du travail

L'accident du travail repose sur trois caractéristiques médico-légales : la matérialité de l'accident, la relation de cause à effet et le caractère professionnel. Ces critères guident la rédaction du certificat médical et l'instruction du dossier (1).

1.2.1. Matérialité de l'accident

La matérialité correspond à l'existence d'un fait accidentel réel ayant entraîné un préjudice corporel. Elle associe la lésion corporelle, la soudaineté de l'événement et l'origine extérieure. La lésion peut être *une plaie, une contusion, une entorse, une luxation, un lumbago aigu, une fracture, une brûlure thermique ou caustique, une intoxication aiguë, une électrisation, une noyade, une piqûre septique, une morsure, une projection oculaire ou un polytraumatisme.*

La soudaineté demeure le critère qui distingue le plus clairement l'accident de la maladie professionnelle. L'accident est datable et individualisable ; la maladie professionnelle résulte plus souvent d'une exposition habituelle, prolongée ou répétée. L'origine extérieure renvoie à un agent externe : chute, choc, machine, outil, produit chimique, agent biologique, courant électrique, irradiation, effort brutal ou agression.

1.2.2. Relation de cause à effet

La relation de cause à effet correspond à la cohérence entre l'événement rapporté et les lésions observées. Elle s'apprécie à partir du siège anatomique, de la nature de la lésion, de son intensité, de la chronologie d'apparition des symptômes et de l'évolution clinique. Le médecin doit différencier ce qu'il constate objectivement de ce qui est rapporté par la victime.

1.2.3. Caractère professionnel de l'accident

Le caractère professionnel repose sur le lien avec le travail : temps de travail, lieu de travail, mission confiée, situation assimilée et lien de subordination. Un accident peut être professionnel même hors de l'établissement si le travailleur agit dans le cadre d'une mission ou d'une activité relevant de l'organisation de l'employeur (1,2).



Figure 1. Caractéristiques de l'accident du travail

1.3. Imputabilité médicale

L'imputabilité médicale consiste à rattacher un dommage à un événement générateur. Elle repose sur une méthode et non sur une impression. Les critères classiquement utilisés sont la réalité du traumatisme, son intensité, la concordance de siège, le délai logique entre le traumatisme et le dommage, la continuité des symptômes, la plausibilité scientifique du mécanisme et l'analyse de l'état antérieur.

L'état antérieur ne supprime pas automatiquement l'imputabilité. Il peut être silencieux, révélé, aggravé ou décompensé par l'accident. La formulation médicale doit rester nuancée : le praticien distingue les lésions imputables à l'accident, les affections préexistantes et les séquelles aggravées. Toute affection préexistante dont il est établi qu'elle n'a été ni provoquée, ni révélée, ni aggravée par l'accident ne relève pas de la réparation AT/MP (1).

1.4. Constitution du dossier

1.4.1. Dossier de déclaration

Le dossier initial d'accident du travail comprend habituellement *la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial et l'attestation de travail et de salaire.* Ces pièces permettent à la CNAS d'instruire le dossier, d'apprécier les critères de reconnaissance et de calculer les prestations éventuelles (1,3).

1.4.2. Certificats médicaux

Les certificats médicaux sont des actes engageant la responsabilité du praticien. Ils doivent être lisibles, datés, signés, objectifs, descriptifs et limités aux constatations médicales. Ils ne doivent pas transformer les déclarations du patient en certitudes médicales ou administratives.

1.4.2.1. Certificat médical initial ou de prolongation

Le certificat médical initial (CMI) est établi lors du premier examen médical qui suit l'accident. Il est la pièce maîtresse du dossier et constitue souvent le document de référence pour l'expertise ultérieure. Il doit mentionner l'identité de la victime, l'employeur, la date de l'accident, la date de l'examen, le siège des lésions, leur nature, la latéralité, les constatations utiles à l'origine traumatique ou morbide, les examens complémentaires, les soins prescrits et la durée éventuelle de l'incapacité temporaire de travail (1).

Le certificat de prolongation est établi lorsque la poursuite des soins ou de l'arrêt de travail est médicalement justifiée. Il doit rappeler les lésions initiales, décrire l'évolution, préciser les lésions persistantes et, s'il existe de nouvelles manifestations en rapport avec l'accident, les argumenter. Une lésion non décrite dans le certificat initial est plus difficile à rattacher ultérieurement à l'accident ; d'où l'importance d'une rédaction exhaustive dès le premier examen.

1.4.2.2. Certificat médical final descriptif de guérison ou de consolidation

Le certificat médical final descriptif est établi à l'issue de la période de soins. Il peut être *un certificat de guérison* lorsque les lésions ont disparu sans incapacité permanente, avec retour à l'état antérieur sous réserve de rechute. Il peut être *un certificat de consolidation* lorsque les lésions se fixent et prennent un caractère permanent ou définitif, avec séquelles, entraînant ou non une incapacité permanente indemnisable (1,3).

Le certificat de consolidation décrit l'état de la victime après stabilisation, fixe la date de consolidation et peut indiquer à titre médical les conséquences fonctionnelles observées. La consolidation n'exclut ni l'amélioration ultérieure, ni la rechute, ni l'aggravation. Les certificats peuvent être utilement complétés par les comptes rendus d'hospitalisation, d'imagerie, d'explorations fonctionnelles ou d'avis spécialisés.

1.5. Aggravation et rechute de l'accident du travail

1.5.1. Rechute de l'accident du travail

La rechute n'est pas un nouvel accident. Elle correspond soit à l'aggravation d'une lésion après consolidation, soit à l'apparition d'une nouvelle lésion résultant de l'accident initial, alors que la victime avait été considérée comme guérie ou n'avait jusque-là aucune lésion apparente. Le certificat de rechute ou d'aggravation doit mentionner la date de l'accident initial, la date de rechute, les nouvelles constatations, les examens et la justification médicale du lien avec l'événement initial (1,3).

1.5.2. Aggravation des séquelles

Après consolidation, l'aggravation objectivée des séquelles imputables à l'accident peut justifier une révision du taux d'incapacité permanente, dans les conditions prévues par la réglementation.

Elle doit être distinguée de la rechute, qui correspond à une évolution pathologique imputable à l'accident initial nécessitant un nouveau traitement médical, avec ou sans nouvelle incapacité temporaire de travail.

1.6. Déclaration de l'accident du travail

1.6.1. Procédure de déclaration de l'accident du travail

La victime ou ses ayants droit doivent informer l'employeur dans les vingt-quatre (24) heures, sauf cas de force majeure et sans compter les jours non ouvrables. L'employeur doit déclarer l'accident à l'organisme de sécurité sociale dans les quarante-huit (48) heures à compter du moment où il en a eu connaissance. L'organisme de sécurité sociale transmet l'information à l'inspection du travail compétente (1).

En cas de carence de l'employeur, la déclaration peut être faite par la victime, ses ayants droit, l'organisation syndicale ou l'inspection du travail dans un délai de quatre (04) ans à compter du jour de l'accident. Le médecin doit certifier les lésions sans retarder la prise en charge au motif d'une incertitude administrative.

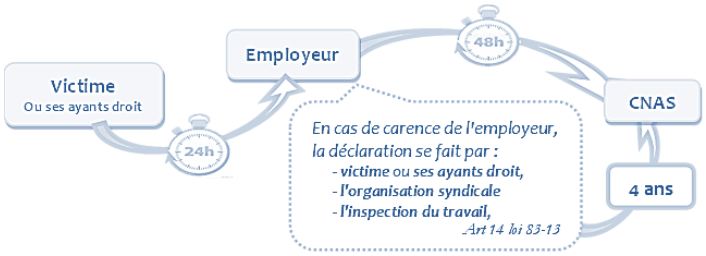


Figure 2. Circuit de déclaration de l'accident du travail

1.6.2. Obligations de l'employeur devant un accident du travail

L'employeur doit déclarer tout accident, même s'il n'a pas entraîné d'incapacité de travail ou lorsqu'il estime que l'accident ne paraît pas imputable au travail. Dans ce dernier cas, il peut accompagner sa déclaration de réserves motivées. Cette obligation favorise la protection de la victime et la traçabilité collective des risques (1).

1.6.3. Attestation de travail et de salaire

L'attestation de travail et de salaire est transmise par l'employeur à la CNAS. Elle permet le calcul des indemnités journalières, de la rente ou du capital représentatif. Le médecin n'en rédige pas le contenu, mais il doit en connaître l'utilité pour orienter la victime et éviter les retards d'indemnisation.

Encadré 1. Circuit simplifié de déclaration d'un accident du travail
Victime/ayants droit → Employeur (24 h) → CNAS (48 h par l'employeur) → Instruction du dossier → Décision de reconnaissance ou de rejet → Prestations éventuelles.

1.7. Données statistiques des AT, accidents de trajet, AT mortels et impact socio-économique

1.7.1. Données nationales consolidées disponibles

Les statistiques AT/MP ont un intérêt scientifique et épidémiologique, financier, épidémiologique et préventif. Elles permettent d'identifier les secteurs à risque, les mécanismes accidentels, les accidents de trajet, les décès, les maladies professionnelles déclarées, les maladies à caractère professionnel et les dépenses générées. En Algérie, les données nationales sont élaborées à partir des déclarations enregistrées par les cellules de prévention AT/MP des agences CNAS, puis consolidées par la Direction de la prévention. Elles concernent les travailleurs salariés affiliés à la CNAS et les principales branches d'activité suivies au niveau national (6).

Le Profil algérien pour la sécurité et la santé au travail 2023 indique que les accidents du travail enregistrés ces dernières années varient globalement entre 40 000 et 50 000 accidents par an (6). Les données nationales présentées ci-après correspondent à la période 2018-2022 et proviennent du Profil algérien pour la SST publié en 2023.

Tableau I. Statistiques nationales CNAS des AT/MP déclarés, 2018-2022 (6).

Indicateur CNAS	2018	2019	2020	2021	2022
Employeurs déclarés	326 174	330 368	349 206	366 485	349 462
Salariés affiliés à la CNAS	5 871 699	5 800 944	5 803 955	5 605 381	5 556 078
AT total déclarés	47 555	49 782	36 275	42 032	42 946
AT sur le lieu de travail	43 974	45 777	33 256	38 225	38 799
AT avec arrêt de travail	41 903	43 683	31 388	35 938	36 830
Accidents de trajet	3 581	4 005	3 019	3 807	4 147
Accidents de trajet avec arrêt	3 343	3 772	2 840	3 596	3 837
AT mortels : total	529	509	424	513	448
AT mortels sur lieu de travail	412	385	335	434	328
AT mortels sur trajet	117	124	89	79	120
MP déclarées	410	520	260	321	216
MCP déclarées	1 012	872	281	4 916	905
Dépenses AT/MP (DA)	26 609 010 209	28 428 604 396	28 666 346 322	30 635 506 542	33 626 535 918

Lecture du tableau : entre 2018 et 2022, le nombre total d'accidents du travail déclarés est passé de 47 555 à 42 946, soit une diminution d'environ 9,7 %. L'année 2020 marque un recul important, probablement influencé par le ralentissement de nombreuses activités pendant la période de pandémie, suivi d'une remontée en 2021 et 2022. En 2022, les accidents de trajet représentaient 4 147 cas, soit près de 9,7 % de l'ensemble des AT déclarés, et 120 décès sur trajet ont été enregistrés parmi 448 AT mortels. Les accidents mortels demeurent donc un indicateur critique de gravité, en particulier pour les secteurs à forte exposition aux chutes, aux engins, aux risques routiers et aux travaux en hauteur (6).

1.7.2. Impact socio-économique

Le coût humain des AT/MP comprend la souffrance physique et morale, les séquelles, la restriction des activités, la perte de revenus, le risque de perte d'emploi, les conséquences familiales et sociales, et parfois le décès. Le coût financier associe les dépenses de soins, les indemnités, les rentes, l'absentéisme, la perte de production, le remplacement de la victime, les dégâts matériels, la formation d'un remplaçant et l'impact négatif sur l'image de l'entreprise. À l'échelle internationale, l'OIT rappelle que les accidents et maladies liés au travail entraînent une charge humaine et économique majeure, justifiant le renforcement des politiques de prévention (7).

Pour le futur médecin, les statistiques ne doivent pas être apprises comme de simples chiffres. Elles doivent être comprises comme un outil de décision : repérer les risques prioritaires, améliorer les déclarations, cibler la surveillance médicale, orienter les enquêtes après accident, renforcer les mesures de prévention et contribuer à la réduction de la sous-déclaration des maladies professionnelles.

2. Maladies professionnelles

2.1. Définitions des maladies professionnelles (MP) et des maladies à caractère professionnel (MCP)

2.1.1. Maladie professionnelle

Selon l'article 63 de la loi n°83-13, sont considérées comme maladies professionnelles les intoxications, infections et affections présumées d'origine professionnelle particulière (1). La maladie professionnelle se distingue de l'accident du travail par son mode de survenue souvent progressif et par la difficulté de fixer un point de départ précis.

L'accident du travail résulte le plus souvent d'une exposition occasionnelle à un fait matériel fortuit, survenu à un moment connu et dans un lieu précis. La maladie professionnelle est la conséquence d'une exposition plus ou moins prolongée à un risque dans l'exercice habituel de la profession; la preuve du lien peut être plus complexe, d'où l'importance des tableaux de maladies professionnelles (1,5).

2.1.2. Maladie à caractère professionnel

La maladie à caractère professionnel (MCP) est une affection suspectée d'être en relation avec un risque particulier d'origine chimique, physique, biologique, ou organisationnelle, ou avec des conditions générales de travail, sans remplir nécessairement les conditions d'un tableau indemnisable. L'article 68 de la loi n°83-13 impose à tout médecin de déclarer toute maladie ayant, à son avis, un caractère professionnel, en vue de l'extension des tableaux et de la prévention (1).

Les MCP peuvent concerner notamment certains troubles musculo-squelettiques, lombalgies, syndromes du canal carpien, tendinopathies, troubles liés aux risques psychosociaux, stress, épuisement professionnel ou affections liées à de nouvelles expositions. Elles n'ouvrent pas droit à réparation en tant que telles, mais elles ont une valeur collective majeure pour la veille sanitaire et la prévention.

2.2. Tableau de maladie professionnelle

2.2.1. Définition du tableau de maladie professionnelle

Le tableau de maladie professionnelle est un outil médico-réglementaire qui organise la présomption d'origine professionnelle. Il associe une maladie déterminée, un délai de prise en charge, parfois une durée minimale d'exposition, et une liste de travaux ou d'expositions susceptibles de provoquer la maladie. Lorsque les conditions du tableau sont réunies, la victime bénéficie d'une présomption d'imputabilité (1,5).

En Algérie, les maladies professionnelles reconnues par le régime de sécurité sociale sont organisées en tableaux annexés à l'arrêté interministériel du 5 mai 1996. Il existe 85 tableaux, répartis en trois groupes : (1) manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques, (2) infections microbiennes et (3) maladies résultant d'ambiances ou d'attitudes de travail (5).

2.2.2. Descriptif d'un tableau de maladie professionnelle

Chaque tableau comporte un numéro et un intitulé, la désignation de la maladie ou de l'agent causal, les symptômes ou lésions pathologiques, le délai de prise en charge, parfois une durée minimale d'exposition, et la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie. Les listes peuvent être indicatives, notamment pour de nombreux tableaux d'intoxication, ou limitatives, notamment pour des infections ou affections liées aux ambiances de travail (5).

Le médecin doit lire le tableau avec méthode : le diagnostic doit correspondre à l'intitulé réglementaire; le délai de prise en charge ne doit pas être confondu avec la latence; la liste des travaux doit être confrontée à l'activité réelle et non au seul intitulé du poste.

Tableau II. Structure pratique d'un tableau de maladie professionnelle.

Numéro du tableau et l'intitulé (Maladie ou agent causal et/ou durée d'exposition)

Colonne de gauche	*Colonne de milieu*	*Colonne de droite*
DÉSIGNATION DE LA MALADIE	**DÉLAI DE PRISE EN CHARGE (DPC)**	**LISTE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CETTE MALADIE**
(liste limitative) **- Lésions et symptômes** **Eczéma, asthme, anémie, …** **- Examens complémentaires** ↓ - **FNS (anémie)** : *saturnisme, RI* - **Rx** : *silicose, asbestose, …* - **EFR** : *asthme professionnel, …* - **Audiogramme** : *surdité prof* - **Sérologie** : *hépatite, brucellose…* - **EMG** : *névrites et polynévrites* - **Tests cutanés** : *eczéma* - **TDM et ex. anat-path** : *Kc prof*	**Correspond à** ***la période qui s'est écoulée entre la date de la cessation du travail exposant au risque*** ↕ ***et celle de la 1ère constatation médicale de la MP*** *- DPC court (lésions aiguës)* *- DPC long (lésions chroniques / kc)*	**- Liste indicative (groupe 1)** *G1 : intoxication au Pb, Hg, Cd, As, Cr, Ni, … le médecin pouvant identifier d'autres travaux ne figurant pas sur cette liste (liste ouverte)* **- Liste limitative (groupe 2 et 3)** *G2 : hépatite, brucellose, leptospirose* *G3 : bruits, vibration, milieu hyperbare, seuls les travailleurs affectés aux travaux énumérés ont droit à la réparation (liste fermée)*

Tableau III. Groupes de tableaux de maladies professionnelles en Algérie.

GROUPE N°1	GROUPE N°2	GROUPE N°3
Manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques TMP N° 1 : maladies causées par le plomb (Pb) et ses composés TMP N° 2 : hydrargyrisme professionnel (MP causée par le mercure (Hg) et ses composés TMP N° 4 : maladies causées par le benzène, le toluène, les xylènes et tous les produits en renfermant TMP N° 6 : affections provoquées par les rayonnements ionisants TMP N° 15 : affections provoquées par les amines aromatiques … TMP N° 84 : affections engendrées par les solvants organiques	**Infections microbiennes** TMP N° 7 : tétanos professionnel. TMP N° 18 : charbon professionnel. TMP N° 19 : leptospiroses professionnelles. TMP N° 24 : brucelloses professionnelles. TMP N° 28 : ankylostomose professionnelle. Anémie engendrée par l'ankylostome duodénal. TMP N° 40 : maladies dues aux bacilles tuberculeux. TMP N° 45 : hépatites virales professionnelles. TMP N° 46 : mycoses cutanées d'origine prof. ... TMP N° 67 : tularémie professionnelle. TMP N° 75 : maladies infectieuses contractées par le personnel de santé. TMP N° 76 : périonyxis et onyxis d'origine prof. TMP N° 79 : kératoconjonctivites virales.	**Maladies résultant d'ambiances et d'attitudes de travail** TMP N° 23 : nystagmus professionnel. TMP N° 29 : milieux hyperbares TMP N° 42 : affections provoquées par les bruits (surdité professionnelle). TMP N° 56 : hygroma du genou. TMP N° 57 : affections provoquées par le travail à haute température. TMP N° 64 : lésions eczématiformes de mécanisme allergique. TMP N° 65 : affections respiratoires professionnelles de mécanisme allergique. TMP N° 68 : affections provoquées par les vibrations TMP N° 70 : affections oculaires dues au rayonnement thermique. TMP N° 78 : lésions chroniques du ménisque. TMP N° 80 : maladies provoquées par l'inhalation de poussières aviaires. TMP N° 83 : milieu hypobare TMP N° 85 : dysphonie professionnelle

2.3. Système de reconnaissance et de réparation des maladies professionnelles

La réparation des maladies professionnelles en Algérie repose principalement sur le système des tableaux et sur la présomption d'origine lorsque les conditions réglementaires sont satisfaites (1,5).

L'intérêt du tableau est de faciliter la reconnaissance et d'alléger la charge de la preuve. Sa limite est de ne pas intégrer immédiatement toutes les pathologies émergentes, les nouveaux produits, les organisations de travail récentes ou les pathologies multifactorielles. C'est pourquoi la déclaration des MCP est essentielle pour l'actualisation des connaissances et des tableaux.

2.4. Présomption d'imputabilité

La présomption d'imputabilité signifie que la maladie est présumée, sauf preuve contraire, imputable au travail et indemnisable au titre des maladies professionnelles lorsque trois conditions sont réunies : *la maladie constatée correspond à une maladie figurant dans un tableau* ; *les travaux réellement exercés sont réputés susceptibles de provoquer cette maladie* ; *le délai de prise en charge du tableau est respecté* (1,5).

La présomption peut tomber si les examens ou contrôles exigés par certains tableaux n'ont pas été réalisés, ou si les ayants droit s'opposent à une autopsie demandée par l'organisme de sécurité sociale sans apporter par ailleurs la preuve du lien entre la maladie et le décès. En principe, sauf disposition contraire, la victime n'a pas à prouver l'intensité de l'exposition lorsque les conditions réglementaires sont remplies (1).

Figure 4. Lecture d'un tableau de maladie professionnelle

Diagnostic exact → Exposition professionnelle réelle → Délai de prise en charge respecté → Durée minimale éventuelle → Liste des travaux compatible → Présomption d'origine professionnelle.

2.5. Déclaration des maladies professionnelles et des maladies à caractère professionnel

2.5.1. Intérêts de la déclaration

La déclaration d'une maladie professionnelle a un intérêt individuel et collectif. Pour la victime, elle ouvre l'instruction du dossier et l'accès éventuel aux prestations. Pour la collectivité, elle améliore la traçabilité des expositions, favorise la prévention et alimente les statistiques. La sous-déclaration des MP est un problème majeur, favorisé par la méconnaissance des tableaux, la complexité des démarches, l'ignorance du lien possible entre travail et symptômes, et parfois la sous-reconnaissance administrative (6).

2.5.2. Procédures de déclaration des MP et des MCP

2.5.2.1. Rôle du médecin

Tout médecin peut établir un certificat médical initial de maladie professionnelle lorsqu'il suspecte une origine professionnelle. La déclaration de MP n'est donc pas réservée au médecin du travail. Le médecin recherche l'exposition, documente le diagnostic, interroge l'activité réelle et oriente la victime vers la procédure CNAS (1).

2.5.2.1.1 Rédaction du certificat médical initial

Le certificat médical initial de MP doit mentionner l'identité du patient, le diagnostic précis, les éléments cliniques et paracliniques, l'activité ou l'exposition suspecte, la date de première constatation médicale et, lorsque cela est possible, le tableau de maladie professionnelle correspondant. Il est remis à l'assuré selon les modalités prévues par les formulaires (ATMP17) de sécurité sociale.

2.5.2.1.2 Déclaration de la maladie à caractère professionnel

La MCP est déclarée à des fins de surveillance, de prévention et d'évolution des tableaux. Elle suit une logique proche de la déclaration de MP, mais n'ouvre pas en elle-même un droit à indemnisation. Elle constitue néanmoins un devoir médical important lorsque le lien avec le travail paraît plausible (1).

2.5.2.4. Rôle de la victime

La victime ou ses ayants droit effectuent la déclaration de MP auprès de la CNAS, à l'aide du formulaire de déclaration de maladie professionnelle (AT 16) et de la reconstitution de carrière. Cette dernière est essentielle pour établir les postes occupés, les produits manipulés, les procédés utilisés, les périodes d'exposition et les mesures de protection.

2.5.2.4.1 Formulaire de déclaration de maladie professionnelle

Le formulaire de déclaration structure la demande de reconnaissance. Il doit être cohérent avec le certificat médical initial et la reconstitution de carrière. Une discordance entre diagnostic, exposition et activités déclarées peut retarder l'instruction.

2.5.2.4.2 Déclaration de reconstitution de carrière

La reconstitution de carrière est déterminante dans les expositions longues, multiples ou anciennes. Elle précise les entreprises, les postes, les dates, les procédés, les produits, les ambiances de travail et les protections. Elle permet de relier la maladie actuelle à une exposition professionnelle cumulative.

2.5.2.7. Rôle de l'employeur

L'employeur contribue à la traçabilité des expositions et à la production des documents nécessaires. Il doit organiser la prévention et signaler l'utilisation de procédés susceptibles de provoquer des maladies professionnelles (1,4).

2.5.2.8. Déclaration d'utilisation de procédés susceptibles de provoquer des maladies professionnelles

Cette déclaration permet aux organismes compétents d'identifier les procédés dangereux et d'orienter les actions de prévention. Elle a une dimension réglementaire, épidémiologique et préventive, en particulier pour les risques chimiques, biologiques, physiques et les procédés industriels à risque (4).

2.6. Statistiques des maladies professionnelles et des maladies à caractère professionnel

Les maladies professionnelles déclarées sont passées de 410 cas en 2018 à 216 cas en 2022, avec un pic à 520 cas en 2019. Les MCP déclarées montrent une forte variabilité, notamment un pic de 4 916 déclarations en 2021, puis 905 en 2022. Cette variabilité doit être interprétée avec prudence, car le Profil algérien pour la SST souligne l'importance de la sous-déclaration des MP et la nécessité d'améliorer le système d'enregistrement, de réviser régulièrement les tableaux et de renforcer la déclaration des maladies à caractère professionnel (6).

Tableau IV. Exemples de maladies professionnelles déclarées selon les affections, 2018-2022 (6).

Maladie professionnelle déclarée	2018	2019	2020	2021	2022
Affections provoquées par les bruits (Tb n° 42)	77	106	48	77	52
Dysphonie professionnelle (Tb n° 85)	50	91	40	43	30
Affections dues aux bacilles tuberculeux (Tb n° 40)	56	65	57	26	26
Maladies causées par le plomb et ses composés (Tb n° 1)	28	27	9	6	33
Hépatites virales professionnelles (Tb n° 45)	22	33	5	14	6
Maladies infectieuses contractées par le personnel de santé (Tb n° 75)	32	25	9	14	6
Affections consécutives aux poussières d'amiante (Tb n° 30)	2	5	4	51	6

La surdité professionnelle liée au bruit reste l'une des affections les plus régulièrement déclarées. Les affections infectieuses, notamment tuberculose et hépatites virales, rappellent l'importance du risque biologique, en particulier dans les secteurs de soins et les activités exposantes. Les maladies liées au plomb, à l'amiante et aux agents allergisants illustrent l'intérêt de la traçabilité des expositions anciennes, de la métrologie et de la surveillance médicale ciblée (6).

Figure 3. Circuit simplifié de déclaration d'une maladie professionnelle

Suspicion clinique → Certificat médical initial MP/MCP → Déclaration par la victime ou ses ayants droit → Reconstitution de carrière → Instruction CNAS → Décision → Réparation éventuelle et prévention.

3. Reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles par la CNAS

3.1. Conditions de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles

3.1.1. Reconnaissance de l'accident du travail

La reconnaissance de l'accident du travail repose sur la réunion des éléments constitutifs : fait accidentel, lésion corporelle, cause soudaine et extérieure, et relation avec le travail. Le temps, le lieu, la subordination, les témoignages et la cohérence médicale sont analysés. La lésion ou le décès survenant au lieu et au temps du travail, ou dans un temps voisin de l'accident, sont en principe considérés comme liés au travail sauf preuve contraire (1).

3.1.2. Reconnaissance de la maladie professionnelle

La reconnaissance d'une maladie professionnelle indemnisable repose sur trois conditions : *une condition médicale*, avec inscription de l'affection dans un tableau ; *une condition administrative*, avec respect du délai de prise en charge et de la durée d'exposition éventuelle ; *une condition professionnelle*, avec des travaux correspondant à ceux prévus par le tableau. Lorsque l'une de ces conditions manque, l'affection peut ne pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle (1,5).

3.1.3. Reconnaissance de la maladie à caractère professionnel

La MCP n'est pas reconnue comme maladie indemnisable. Sa déclaration permet néanmoins d'améliorer la connaissance des pathologies professionnelles, de faire évoluer les tableaux et de renforcer les actions de prévention. Elle constitue un signal sanitaire, même en l'absence de réparation individuelle immédiate (1).

3.1.4. Prise en charge du décès suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle

Lorsque le décès est imputable à un AT ou une MP, les ayants droit peuvent bénéficier des prestations prévues par la législation. L'analyse médicale doit établir le lien entre l'événement ou la maladie reconnue et le décès, en tenant compte des lésions, complications, délais et états antérieurs (1,3).

4. Prestations des accidents du travail et des maladies professionnelles

La reconnaissance du caractère professionnel ouvre droit à des prestations destinées à prendre en charge les conséquences médicales et économiques de l'atteinte. Ces prestations comprennent les prestations d'incapacité temporaire, d'incapacité permanente et les prestations en cas de décès (1,3).

4.1. Prestations d'incapacité temporaire

4.1.1. Prestations en nature

Les prestations en nature couvrent les frais nécessaires au traitement de la victime : *soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitalisation, examens biologiques, radiologiques, endoscopiques ou isotopiques, soins dentaires, optique médicale, appareillage, prothèses, rééducation fonctionnelle, réadaptation professionnelle et transport médicalement justifié* (3).

Les soins en rapport avec l'AT/MP sont pris en charge selon les règles applicables et peuvent se poursuivre au-delà de la guérison ou de la consolidation aussi longtemps que l'état de la victime justifie la continuation du traitement. Les prestations en nature sont au cœur de la réparation médicale et de la réinsertion fonctionnelle (3).

4.1.2. Prestations en espèces

Les prestations en espèces compensent la perte de revenu pendant l'incapacité temporaire. Elles prennent principalement la forme d'indemnités journalières versées pendant la période d'arrêt de travail, jusqu'à la guérison, la consolidation ou le décès, ainsi qu'en cas de rechute ou d'aggravation reconnue (1,3).

4.1.3. Indemnités journalières

Les indemnités journalières sont versées à partir du jour suivant l'arrêt de travail consécutif à l'accident ou à la maladie professionnelle, selon les modalités prévues par la législation. Leur calcul nécessite l'attestation de travail et de salaire transmise par l'employeur (3).

4.2. Prestations d'incapacité permanente

L'incapacité permanente correspond à la réduction durable de la capacité physique, fonctionnelle ou professionnelle après consolidation. Elle est évaluée selon un barème et peut tenir compte du retentissement social et professionnel de la séquelle (1).

4.2.1. Capital représentatif

Lorsque le taux d'incapacité permanente partielle est inférieur au seuil ouvrant droit à rente (< 10 %), la réparation peut prendre la forme d'un capital représentatif. Il s'agit d'un *versement unique non révisable*, correspondant à la réparation forfaitaire de la séquelle reconnue (1,3).

4.2.2. Rente

La rente est servie lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 10 %. Elle vise à compenser une perte durable de capacité de gain et peut être révisée en cas de rechute, d'aggravation ou de modification reconnue de l'état de la victime (1,3).

4.2.3. Taux social

Le taux social peut compléter le taux médical afin de tenir compte de l'âge, de la situation familiale et sociale, des aptitudes, de la qualification professionnelle et des possibilités de reclassement. Deux victimes présentant une séquelle anatomique comparable peuvent avoir un retentissement professionnel différent.

Conformément à l'article 42 de la loi n° 83-13, modifié par l'ordonnance n° 96-19 du 6 juillet 1996, le taux social, compris entre 1 % et 10 %, est accordé aux assurés sociaux dont le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 10 %.

4.2.4. Majoration de la rente pour tierce personne

Lorsque l'état de la victime impose l'assistance d'une tierce personne pour les actes essentiels de la vie courante, une majoration de la rente peut être envisagée. Cette situation doit être documentée par une évaluation clinique, fonctionnelle et sociale précise (1).

4.3. Prestations en cas de décès

4.3.1. Allocation-décès

En cas de décès imputable à un AT/MP, un capital décès peut être versé aux ayants droit selon les conditions réglementaires. Le lien entre le décès et l'événement ou la maladie professionnelle doit être établi (1,3).

4.3.2. Rente de réversion ou rente des ayants droit

En cas de décès consécutif à un AT ou à une MP, les ayants droit bénéficient, selon les conditions légales, de rentes calculées sur la base de la rémunération de référence de la victime.

En cas de décès non consécutif à l'accident d'un titulaire d'une rente d'accident du travail, les ayants droit peuvent bénéficier d'une rente de réversion calculée sur la base de la rente du défunt, dans les conditions prévues par la législation.

La rente de réversion ou rente des ayants droit s'inscrit dans la logique de réparation sociale des conséquences économiques du décès professionnel. Elle vise à protéger les proches de la victime lorsque le décès est reconnu imputable à l'AT/MP (1,3).

Tableau V. Prestations servies au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP).

Prestations d'incapacité temporaire (ITT)	Prestations d'incapacité permanente (IPP)	Prestations en cas de décès
Situation : arrêt temporaire du travail.	**Situation :** incapacité permanente partielle ou totale après consolidation.	**Situation :** décès imputable à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Prestations en nature : prise en charge intégrale des soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de rééducation et d'appareillage.	**Capital représentatif** : versé en une seule fois lorsque le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) est inférieur à 10 %. Ce capital n'est pas révisable.	**Capital décès** versé aux ayants droit selon les dispositions réglementaires en vigueur.
Prestations en espèces : indemnités journalières destinées à compenser la perte de salaire pendant la période d'incapacité temporaire de travail.	**Rente mensuelle** : attribuée lorsque le taux d'IPP est égal ou supérieur à 10 %. La rente peut être révisée en cas d'aggravation ou d'atténuation de l'infirmité.	**Rentes des ayants droit en cas de décès imputable à l'AT/MP** attribuée aux bénéficiaires légaux lorsque le décès est reconnu imputable à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Soins et réadaptation professionnelle : mesures favorisant la récupération fonctionnelle et la réinsertion professionnelle du travailleur victime.	**Taux social** : majoration comprise entre 1 % et 10 % pouvant être accordée en fonction des conséquences sociales et professionnelles de l'incapacité.	Assure la protection sociale et économique de la famille de la victime.
	Majoration pour tierce personne : augmentation de la rente lorsque l'état de la victime nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne pour les actes essentiels de la vie quotidienne. Cette majoration est fixée à 40 %.	

5. Synthèse pratique et prévention

La réparation intervient après le dommage; la prévention cherche à éviter sa survenue ou sa récidive. La démarche moderne de prévention privilégie la suppression du danger à la source, la substitution, les mesures techniques collectives, l'organisation du travail, la formation, la surveillance des expositions et de la santé, puis les équipements de protection individuelle en complément. Cette hiérarchie est cohérente avec les principes internationaux de gestion de la sécurité et santé au travail (8,10).

Figure 4. Hiérarchie des mesures de prévention des AT/MP

1. Supprimer le danger → 2. Substituer → 3. Protéger collectivement → 4. Organiser le travail et former → 5. Surveiller les expositions et la santé → 6. Utiliser les EPI en complément.

5.1. Rôle du médecin du travail et des acteurs de prévention

Le médecin du travail intervient au plus près de l'activité réelle. Son rôle n'est pas seulement de participer au dépistage ou à la déclaration ; il consiste surtout à anticiper le risque par l'étude du poste, la surveillance des conditions de travail, l'analyse des expositions et le conseil auprès de l'employeur et des travailleurs. Il contribue à la traçabilité individuelle et collective des expositions, notamment pour les risques chimiques, biologiques, physiques et ergonomiques (4).

Lorsqu'un accident survient, l'analyse ne doit pas rechercher uniquement une faute individuelle. Elle doit identifier les causes immédiates et profondes : organisation du travail, formation insuffisante, défaut de protection collective, matériel inadapté, procédures non appliquées, contraintes temporelles, fatigue, intérim ou sous-traitance. Cette approche systémique permet de transformer l'événement dommageable en action de prévention.

5.2. Sous-déclaration et enjeux de santé publique

La sous-déclaration des maladies professionnelles est un phénomène classique. Les chiffres déclarés ne reflètent pas toujours la réalité du terrain. Les causes sont multiples : méconnaissance des tableaux par les médecins, ignorance des risques par les travailleurs, complexité des démarches, crainte de conséquences professionnelles, insuffisance de traçabilité des expositions et limites du système de reconnaissance.

La lutte contre la sous-déclaration relève d'une responsabilité partagée. Elle suppose la formation des médecins, l'information des travailleurs, l'amélioration de la traçabilité, l'accès aux fiches de données de sécurité, la surveillance médicale ciblée, l'analyse des postes et la simplification de l'orientation administrative. Déclarer correctement ne sert pas uniquement à indemniser ; cela permet aussi de prévenir les cas similaires.

Bibliographie

1. Loi n°83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
2. Ordonnance n°96-19 du 6 juillet 1996 modifiant et complétant la loi n°83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles.
3. Décret n°84-28 du 11 février 1984 fixant les modalités d'application des titres III, IV et VIII de la loi n°83-13 relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles.
4. Décret exécutif n°97-424 du 11 novembre 1997 fixant les conditions d'application du titre V de la loi n°83-13 relatif à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
5. Arrêté interministériel du 5 mai 1996 fixant la liste des maladies présumées d'origine professionnelle ainsi que ses annexes.
6. Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Profil Algérien pour la Sécurité et la Santé au Travail. Alger: MTESS; 2023.
7. International Labour Organization. Nearly 3 million people die of work-related accidents and diseases. Geneva: ILO; 2023.
8. International Labour Organization. List of occupational diseases (revised 2010): identification and recognition of occupational diseases. Geneva: ILO; 2010.
9. World Health Organization. Occupational health: health workers. Geneva: WHO; 2022.
10. International Organization for Standardization. ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use. Geneva: ISO; 2018.